SDD 128 Sujet n°X

Spécialité : neurologie

Date : 16/01/2024
Auteur : Nolwenn BILLET (spécialité neurologie, ECN 2022)
Relecteur(s) : Lucie-Lou VIAL (EDN 2024 MAR Toulouse)

une station ECOS

Domaine d'apprentissage principal	Examen clinique
Domaine d'apprentissage secondaire	Entretien/interrogatoire
Item(s) en lien avec la station	106 – Maladie de Parkinson
Situation(s) de départ en lien avec la station	128 – Tremblement
Matériel nécessaire à la station	Marteau réflexe Une table Deux chaises
Contexte de la station	Consultation de médecine générale

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes médecin généraliste en cabinet.
Vous recevez Monsieur JAMES, âgé de 68 ans, dans votre cabinet qui se présente seul à la consultation.

Il a pour principaux antécédents une HTA, un DNID et une presbyacousie appareillée. Son traitement comporte de l'ENALAPRIL et du BISOPROLOL, de la METFORMINE et du PARACETAMOL en si besoin.

Il est marié, a deux enfants vivant à proximité, et est un ancien technicien de laboratoire à la retraite.

Constantes : FC 76, TA 137/86, sat 98%.

Il se plaint d'un tremblement évoluant depuis quelques mois et face auquel vous suspectez un syndrome parkinsonien.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Poursuivre un interrogatoire ciblé.
- Réaliser un examen clinique ciblé pour confirmer le diagnostic (expliquez à haute voix ce que vous cherchez).

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec patient standardisé

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
Rubrique 1 : Interrogatoire symptomatique		
1.	Recherche du caractère de repos ou d'action du tremblement.	1 pt
2.	Recherche de la symétrie du tremblement.	1 pt
3.	Recherche d'une aggravation lors de la concentration ou de l'émotion.	1 pt
4.	Recherche de symptômes non moteurs : (2 parmi) - Troubles de l'humeur. - Perte ou diminution de l'odorat. - Troubles du sommeil. - Constipation ou urgenturies.	1 pt
5.	Recherche une bradikinésie	1 pt
6.	Recherche une rigidité plastique	1 pt
Rubrique 2 : Recherche de drapeaux rouges		
5.	Rechercher des chutes précoces.	1 pt
6.	Rechercher des atteintes pseudo-bulbaires (dysarthrie et dysphagie).	1 pt
7.	Rechercher une perte d'autonomie et des troubles cognitifs.	1 pt
8.	Rechercher une dysautonomie sévère.	1 pt
9.	Rechercher une prise de neuroleptiques.	1 pt
Rubrique 3 : Examen clinique		
10.	Énonce la nécessité d'évaluer la marche du patient	1 pt
11.	Recherche d'une roue dentée. - poignets et bras. - position assise ou debout. - Action à faire : rotation passive du poignet avec avant-bras maintenu par l'examinateur.	1 pt

12.	Rechercher un ralentissement des gestes alternatifs rapides (opposition pouce-index, battre la mesure, marionnettes).	1 pt
13.	Rechercher l'absence de syndrome pyramidal (2 signes parmi) : - Réflexes vifs. - Signe de Babinski. - Signe de Hoffmann. - Trépidation épileptoïde. - Rigidité spastique.	1 pt
14.	Rechercher des signes de syndrome cérébelleux.	1 pt
15.	Rechercher une atteinte oculomotrice.	1 pt
	Communications et attitudes	
	1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair	1 pt

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

	2. APTITUDE À QUESTIONNER	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

	4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

	9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE	1 pt	☐

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL (max 20 items)	**…/20 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>

Face à un tremblement de repos, la principale hypothèse est celle d'un syndrome parkinsonien et en premier lieu une maladie de Parkinson idiopathique.

Il convient de rechercher la triade diagnostique clinique Akinésie/Bradykinésie-Rigidité-Tremblement, mais aussi de rechercher d'éventuels drapeaux rouges orientant vers d'autres causes de syndrome parkinsonien.

La recherche d'une prise de neuroleptique et de neuroleptiques cachés est indispensable également dans la prise en charge.

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le/La candidat.e reçoit Monsieur JAMES en consultation de médecine générale pour un tremblement de repos ayant débuté il y a quelques mois et dont il ne s'était pas préoccupé auparavant.

Plan de la station ECOS :

Le patient est assis sur une chaine en face du/de la candidat.e.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour docteur, j'ai remarqué que mes mains tremblaient parfois au cours de la journée et que cela s'aggrave depuis plusieurs mois.

Identité du patient :

Monsieur Jean-Martin JAMES, 68 ans, 1m74 pour 88 kg.

Mode de vie :

Ancien technicien de laboratoire à la retraite.
Il est marié, a deux enfants, deux filles de 42 et 37 ans en bonne santé.
Il aime jardiner et faire de longues marches avec son épouse.
Il ne fume pas et consomme de l'alcool occasionnellement les week-ends.

Comportement global :

Peu expressif, garde le visage figé, ne sourit pas.

Antécédents personnels :

HTA, DNID, presbyacousie appareillée.

Antécédents familiaux :

Aucun.

Médicaments :

ENALAPRIL 20 mg une fois par jour
BISOPROLOL 2,5 mg une fois par jour
METFORMINE 500 mg trois fois par jour
PARACETAMOL, si besoin (n'en a pas pris depuis plusieurs mois)

Symptômes positifs d'interrogatoire :

Si le candidat demande quand est-ce que le tremblement survient : « quand je suis assis et que je regarde la télé ».
Si le candidat demande si l'un des côtés est plus touché que l'autre : « oui le côté droit, et cela me gêne pour écrire ».

Si le candidat demande si le patient présente : répondre « oui j'ai remarqué cela ».

- Perte ou diminution de l'odorat.
- Constipation ou urgenturies.
- Un retentissement sur ses activités (« ne peut plus jardiner comme avant »).

Si le candidat demande si le patient présente : répondre « non je n'ai pas cela ».

- Troubles de l'humeur.
- Troubles du sommeil.
- Douleurs.
- Une fatigue inhabituelle.
- Une perte de poids récente.
- Des chutes.
- Une dysarthrie ou une dysphagie.
- Des troubles de l'attention, de l'orientation ou de la mémoire.
- Des signes d'hypotension orthostatique (chutes, "voile noir", sensations de faiblesses au lever).
- Pris d'autres traitements que ceux inscrits sur son ordonnance.
- Un tremblement empêchant certaines actions.

Symptômes positifs d'examen clinique (tout examen réalisé par le candidat médecin qui n'apparaît pas dans ce tableau devra donner lieu à une réaction normale) :

Si le candidat médecin fait :	Comment réagir :
Demander de marcher normalement	… Marcher à petits pas le dos légèrement voûté, décomposer le demi-tour et sans ballant du bras à droite.
Demander de marcher sur la pointe des pieds ou sur les talons…	… Le faire normalement.
Demander de tenir en équilibre pieds joints yeux ouverts et fermés…	… Le faire normalement.
Si demande de tendre les deux mains devant soi sans bouger…	… Le faire normalement.
Si recherche d'une roue dentée…	… Dire que le mouvement cède par à-coups.
Si demande de faire les marionnettes, battre la mesure ou réaliser plusieurs fois une opposition pouce index…	… Le réaliser lentement et avec difficulté.
Tester les réflexes avec un marteau réflexe…	… Dire que les réflexes sont normaux.
Si recherche un signe de Babinski (stimule la plante du pied le long du bord externe, puis revient vers la base du gros orteil).	… Dire que cela ne fait rien au niveau du gros doigt de pied.
Si recherche d'un signe de Hoffmann (pression vive sur l'ongle du majeur) …	… Dire que cela ne fait rien de spécial.
Si réalise un examen oculomoteur (suivre le doigt des yeux) …	… Le faire normalement, dire qu'il n'y a pas de mouvement anormal des yeux.
Si demande de réaliser une manœuvre doigt-nez (bout du doigt sur le bout du nez de façon alternative) …	… Le faire normalement.

Constantes :

FC 76, TA 137/86, sat 98%

Questions de relance :

- Si les réflexes n'ont pas été testés : « à quoi ça sert ? » (en désignant le marteau réflexe à disposition du candidat).
- Si la marche n'a pas été testée dire « je ne peux plus faire de marches aussi longues qu'avant ».

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

Plan de la station ECOS :

Patient assis de l'autre côté du bureau réservé au candidat.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Un marteau réflexe
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours